

Detalles del evento

Registrado por	Geraldine Pulido Bello
Fecha reporte	2025-12-16
Fecha del suceso	2025-12-16 01:06 pm
Servicio quien reporta	Auditor
Servicio de ocurrencia	Urgencias
Nombre del paciente	OSCAR GUILLERMO CASALLAS FLORIAN
N° de identificación	1074888457
Asegurador	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS - ARL
Habitación	Urgencias
Edad (en años)	33
Sexo	Masculino
Estado de conciencia del paciente antes del evento	Normal
Reporte relacionado con	Otros
Descripción de lo ocurrido	Evento notificado por aseguradora: ''Paciente OSCAR GUILLERMO CASALLAS FLORIAN CC 1074888457, hospitalizado desde el 06/12 por fractura de T12. La cirugía fue diferida hasta el 14 de diciembre por falta de disponibilidad del especialista, generando falla en la oportunidad y calidad de atención''.
Cargo	Auditor externo

Factores

Categoría

Categoría

Falla en el procedimiento asistencial

Tipo de Suceso Identificado

Cancelacion de cirugia

Cronologia del Suceso

5/12/2025 3:11:28 a. m.

Motivo de Consulta: Fractura vertebral, trauma en la mina

Enfermedad Actual:

Paciente masculino de 33 años ingresa en ambulancia remitido de Hospital de Ubaté, por cuadro clínico de 1 dia de

evolución de accidente laboral, consistente en trauma por aplastamiento en región de tórax y columna lumbosacra, refiere que quedó aprisionado con un coche minero. Niega alteraciones del estado de conciencia o dolor abdominal, no hay emesis no hay pérdida de esfínteres. En dicha institución realizan radiografía de columna lumbosacra encontrando fractura por aplastamiento con acúñamiento anterior del cuerpo vertebral T12, radiografía de reja costal, tórax y caderas normales. Remiten para realización de tomografía de columna rotatoria y valoración por cirujano de columna. Al ingreso signos vitales con TA normal, saturando adecuadamente, sin fiebre. Al examen físico con dolor a la palpación en línea media a nivel de columna de T12, limitación para la movilización del tronco por dolor. Se considera paciente con fractura por aplastamiento con acúñamiento anterior del cuerpo vertebral T12, indico ingreso para manejo analgésico IV, toma de TC columna torácica y valoración por cirujano de columna. Paciente entiende y acepta.

5/12/2025 12:13:20 p. m.

****CX DE COLUMNA****

PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE CAIDA, CON DOLOR TORACOLUMBAR SECUNDARIO, LIMITADO PARA MOVILIDAD POR ESTO

-ANTECEDENTES NIEGA

-EF: ALERTA, ORIENTADA. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS EN TODOS LOS PLANOS, SIEMETRIA FACIAL. PARES CRANEALES BAJOS SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

-TAC DE CLS 05/12/2025: FX A NIVEL DE T12 CUERPO VERTEBRAL CON PERDIDA MAYOR AL 60%

-ANALISIS PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD FX A NIVEL DE T12, CON DOLOR TORACOLUMBAR, A QUIEN SE INDICA MANEJO QUIRURGICO PARA FIJACION DE CANAL. SE HABLA CON PACIENTE, SE EXPLICA CONDUCTA Y SE ACLARAN DUDAS

SE SOLICITA VALORACION ANESTESIOLOGIA Y TAC DE CLS

6/12/2025 7:47:08 a. m.

****CX DE COLUMNA****

PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD CON DX DE:

-FX T12

DOLOR TORACOLUMBAR AXIAL

-EF: ALERTA, ORIENTADA. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS EN TODOS LOS PLANOS, SIEMETRIA FACIAL. PARES CRANEALES BAJOS SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

-ANALISIS PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD FX A NIVEL DE T12, CON DOLOR TORACOLUMBAR, PROGRAMADO PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EL DIA DEMANANA

SE INDICA PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO

PENDIENTES A EVOLUCION

7/12/2025 12:07:10 p. m.

****CX DE COLUMNA****

PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD CON DX DE:

-FX T12

DOLOR TORACOLUMBAR AXIAL

-EF: ALERTA, ORIENTADA. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS EN TODOS LOS PLANOS, SIEMETRIA FACIAL. PARES CRANEALES BAJOS SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

-ANALISIS PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD FX A NIVEL DE T12, EN PLAN QUIRURGICO, PENDIENTE VALORACION ANESTESIOLOGIA PARA DEFINIR PROGRAMACION

PENDIENTES A EVOLUCION

8/12/2025 12:34:25 p. m.

****CX DE COLUMNA****

PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD CON DX DE:

-FX T12

DOLOR TORAOCLUMBAR AXIAL

-EF: ALERTA, ORIENTADA. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS EN TODO LOS PLANOS, SIEMTRIA FACIAL. PARES CRANEALES BAJOS SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

-ANALISIS PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD FX A NIVEL DE T12, EN PLAN QUIRURGICO, SE PROGRAMARA SEGUN DISPONIBILIDAD DE SALAS Y CONCEPTO ANESTESIOLOGIA
PENDIENTES A EVOLUCION

8/12/2025 6:39:46 p. m.

VALORACIÓN PREANESTÉSICA

Paciente: Óscar Guillermo – 33 años

Procedimiento: Fijación vertebral por fractura T12

Paciente masculino de 33 años, previamente sano, sin antecedentes patológicos, quirúrgicos, anestésicos, transfusionales, tóxicos ni alergias conocidas. Funcionalidad previa conservada (≈4 METs). Ingresó por caída con dolor toracolumbar. TAC evidencia fractura de T12 con pérdida mayor al 60% del cuerpo vertebral, sin déficit neurológico asociado. Dolor limita movilidad pero se mantiene estable hemodinámicamente.

antecedentes

patologicos niega

quirurgicon niega

anestesicos niega

alergico: al ibuprofeno

Examen físico y estado actual

Paciente alerta, orientado, cooperador. Pupilas isocóricas reactivas, pares craneales íntegros. Fuerza 5/5 y sensibilidad conservada en las cuatro extremidades. Dolor localizado en región toracolumbar.

Sin signos de dificultad respiratoria, perfusión adecuada

Valoración detallada de vía aérea

Mallampati I-II

Apertura oral ≈3 cm

Distancia tiromentoniana ≈6 cm

Distancia esternomentoniana ≈12 cm

Protrusión mandibular clase I

Movilidad cervical conservada

Dentadura sin prótesis ni piezas móviles

Conclusión: Vía aérea favorable, bajo riesgo de dificultad en ventilación o intubación.

Paraclínicos e imágenes

Hemograma, electrolitos y función renal dentro de rangos esperados.

TAC de columna: fractura inestable T12 (≈60% pérdida de cuerpo vertebral).

No alteraciones neurológicas ni sistémicas que contraindiquen cirugía.

Scores de riesgo

ASA II

Índice de Lee: 0 puntos (Clase I – riesgo cardiaco bajo)

ARSCAT: Riesgo bajo de complicaciones pulmonares

POSPOM: Muy bajo riesgo perioperatorio

Capacidad funcional: 4 METs

Paciente joven, asa II sin comorbilidades, con adecuada reserva cardiopulmonar y vía aérea favorable. Riesgo anestésico global bajo-moderado, principalmente por, Cirugía de columna en prono, Potencial sangrado intraoperatorio, No se identifican predictores de vía aérea difícil, inestabilidad hemodinámica o compromiso respiratorio.

****Plan anestésico**

Ayuno: 8 h sólidos / 2 h líquidos claros.

Acceso venoso 18G o mayor.

Monitoreo estándar; considerar línea arterial según evolución.

Suspender anticoagulación profiláctica 12 horas previas al procedimiento
pendiente firma de consentimiento informado

9/12/2025 2:55:30 p. m.

****CX DE COLUMNA****

PACIENTE DE 33 AÑOS DE EDAD CON DX DE:

-FX T12

DOLOR TORAOCLUMBAR AXIAL

-EF: ALERTA, ORIENTADA. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS EN TODOS LOS PLANOS, SIEMTRIA FACIAL. PARES CRANEALES BAJOS SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

-ANALISIS

SERA LLEVADO A CIRUGIA DIA VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ANALGESIA ORAL

TERAPIA EN CAMA

11/12/2025 10:56:27 p. m.

RESPUESTA DE INTERCONSULTA

MEDICINA INTERNA

PACIENTE CON IDX

-FRACTURA DE T12 INESTABLE

- DINSEA A ESTUDIO

- DERRAME PLEURAL BILATERAL CON ATELECTASIA DEL LOBULO SUPERIOR

SUBJETIVAS

REFIER DISNEA LEVE DESDE EL DIA DE L ACCIDENTE , SIN FIEBRE SIN TOS REFIERE DOLOR EN REGION DE DORSO IZQUIERDO REFIERE QUE ES UNA MOLESTIA QUE LE GENERO DESPUES DLE TRAUMA NIEGA SINTOMAS RESPIRATORISOS ANTES Y REFIERE LEVE PERIDA DE PESO NO CUANTIFICADA DESDE HACE 6 MESES Y QUE ADEMAS ANTES DEL ACCIDENTE VENIA CON SINTOMAS GRIPALES NIEGA FIEBRE

-EF:

TA 110/75 FC 68 T 36.5 SAT 94%

ALERTA, ORIENTADO. PUPILAS ISOCORICAS REACTIVAS DE 3MM,

CUELLO NO MASAS NO MEGALIAS NO SOPLOS

RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN ASOCIADOS

CON DISMINUCION DE TRASMISION DE MURMULLO VESICULAR EN AMBAS BASES ESCASOS ESTERTORES
ABDOMEN NO MASA SNO MEGALIA SNO SOPLOS
EXTREMIDADES NO EDEMAS
LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS
NEUROLÓGICO SIN DEFICIT
SIN ALTERACIONES FUERZA 5/5,
NO DEFICIT

PARACLINICOS

10/12/2025 CR 0.64 BUN 18.5
LEUCOS DE 14.7 HTC 41.4 PLAQ 208000N NET 5480 LINF 2560
TAC DE TORAX DERRAME PLEURAL BILATERAL CON ATELECTASIA DEL PARENQUIMA PULMONAR SUBYACENTE
MICRONUDULOS APARENTMENTE ALEATORIOS EN LOBULOS SUPERIO IZQUIERDO A CORRELACIONAR CON
ANTECEDENTES EXPOSICIONALES,

-ANALISIS

PACIENTE DE 33 AÑOS TRABAJA CON MINAS DE CARBON EN MANEJO HOSPITALARIO POR FX DE COLUMA EN
PROGRAMACION PARA INTERVENCION QUIEN AL MOMENTO REFIERE DISNEA POR LO QUE TOMAN TAC DE TORAX CON
EVIDENCIA DERRAME LIBRE BILATERAL Y ATELECTASIA SIN CLINICA INFECCIOSA Y CON ANTECEDENTES EXPOSICIONALES
SIN CLINICA DE FALLA CARDIACA, SIN CLINICA CLARA DE TB SIN MEBARGO CON SINTOMAS B PERDIDA D EPESO NO
OBJETIVADA CLARAMENTE, CONSIDERO TOMA DE ECO PLEURAL VER SI SE PUEDE DRENAR EL LIQUIDO PARA ESTUDIO
Y VER SI ESTA TABICADO A ESE ESTUDIO HAY QUE HACERLE TANTO ESTUDIO MICROBIOLOGICO COMO CITOQUIMICO
ADEMAS SE DEBE HACER BACILOSCOPIAS Y CULTIVO DE ESPUTO Y TOMA TAC DE TORAX CON CONTRASTE PARA
ESCLARECER HALLAZGOS EN TACAR NO DESCRATO CONTUSION PULMONAR .
SE INDICA ADEMAS TOMA DE ALBUMINA
CON ESTUDISO DEFINIR CONDUCTA
AJUSTAR APOORTE DE LIQUIDOS LR 70 CCHORA
CUANTIFICAR GU
CONSIDERO PRUDENTE ESPERAR BACILOCOPIAS PARA DEFINIR TIEMPO DE INTERVENCION QUIRURGICA

BONILLA
MEDICINA INTERNA

12/12/2025 9:58:59 a. m.
CIRUGIA DE COLUMNA

IDX
FRACTURA DE T12

PROCEDIMIENTO
FIJACION DE COLUMNA DORSOLUMBAR VIA POSTERIOR
CORRECCION DE CIFOSIS POSTRAUMATICA
LAMINECTOMIA

CIRUJANO
GUSTAVO GILON

ORDENES MEDICAS
TRASLADO A RECUPERACION Y POSTERIORMENTE A PISO
ANALGESIA ENDOVENOSA
CEFAZOLINA 1GR IV CADA 8 HORAS
RX DE COL DORSOLUMBAR HOY PM
TERAPIA FISICA FEURA DE CAMA MAÑANA AM